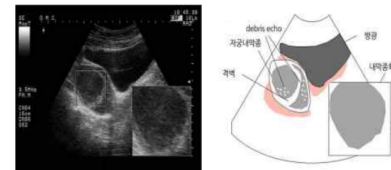


13주차 5. 속발성 월경통

[1] 자궁내막증 ★★★

★자궁샘근증과 자궁내막증의 주요 임상 증상을 2가지 '19 ★자궁내막증의 정의와 임상적의 '11,14,18 ★자궁내막증식증의 위험인자, 원인질환 '12,14(+병리기전),18 ★자궁내막증 골반통의 특징적 증상과 난임이 되는 기전 '12 ★(자궁내막증)은 자궁내막조직이 자궁강 외에 존재하여 증식하는 질환으로 월경곤란증, 성교통, 배변통 등의 증상, 진단엔 초음파검사가 도움되나 확진은 (복강경)으로 한다. '05

정의	자궁내막 移位증 (자궁내막 조직이 위치를 옮긴 것) / 이소성(異所性) 자궁내막, 자궁내막종, 痛經, 癥瘕라고도 함 / 자궁내막의 분비샘과 조직이 비정상적으로 증식한 것.	
호발연령	30 대 이상(35 세 최대) : 요즘은 이 이하 연령층에서도 호발	
가족력	직계가족 유병상태 7-10 배 (보통 8 배)	
발생가설	월경혈의 역류, 체강상피화생설, 유전적 및 면역학적 요인 (보통은 macrophage 가 흡수하여 버려야 하는데, 이 과정에 문제가 생긴 경우)	
원인질환	PCOS	
위험인자	비만 (피하지방에서 estrone 생성 → 증식성 자극)	
병리기전	- 자궁내막증의 경우, E2의 농도가 배란의 조건(200pg/ml 이상으로 50시간 이상 분비)을 충족하지 못해 배란 잘 일어나지 않음. - 따라서 ★P에 의해 억제되지 않은 E의 지속적인 자궁내막 자극에 의해 자궁내막증 발생 배란의 조건 충족X → 배란X → 황체 형성X → 황체가 분비하는 P, E2 분비X → P이 E를 억제하지 못함 → E가 자궁내막을 지속적으로 자극 ∴ 자궁내막증식증 발생	
	[추가적인 병리기전 참고] - 자궁 기저부보다 난관이 아래에 위치하기 때문에, 월경 시 높은 압력에 의해 월경혈이 난관으로도 빠져나갈 수 있음 ⇒ 월경혈이 난관을 통해 복강내로 들어가게 됨 - 정상적으로 장의 바깥쪽인 복강은 무균상태로, 월경혈과 같은 이물질이 유입될 경우, 대식세포(macrophage) 등이 이를 분해함 - But, 자궁내막증의 경우 복강으로 빠져나온 자궁내막을 이물질로 인식하지 못해 대식세포의 청소활동이 일어나지X - 결과적으로 월경 때마다 자궁내막이 쌓이고, 난소의 호르몬 활동에 반응하여 그 위치에서 증식하게 됨.	
증상 (임상의의)	① 임신률 저하	난소 및 자궁부속기 침범, 난소, 난관에 유착 → 난관 운동성 저하 → 난자포획 장애로 임신률 저하
	② 월경통/만성골반통	[물리적] 이소성 자궁내막이 장막과 자궁에 유착되어 → 월경 시 자궁이 팽창, 수축할 때마다 통증 유발 → 월경통 [화학적] 이소성 자궁내막에서 나오는 화학적 물질이 복막에 독소처럼 작용 → 복막의 화학적 작용으로 월경통
	③ 성교통	유착 있는 상황에서 성교 → 통증
	④ 골반외 부위의 자궁내막증	폐색전(폐), 비강출혈(코) 등 골반외 부위에서 자궁내막조직이 발견되고, 이것이 문제 유발 자궁내막 조직이 난관 타고 복강 내로 흘러들어가 난소/난관/자궁결명의 체부 뿐만 아니라 방광결면/폐/비점막까지 이동하여 폐색전 유발하거나 비점막에서 월경기에 비강출혈 일으키는 대장성 월경 유발
진단	초음파검사 / Sono(많이 이용하나, 확진은 아님), 진단적 복강경, CA125	
치료	어혈의 범주 / 복강경 수술로 혈종 제거 → 혈종 제거 후 다시 쌓이는 것을 방지하기 위해 GnRH	



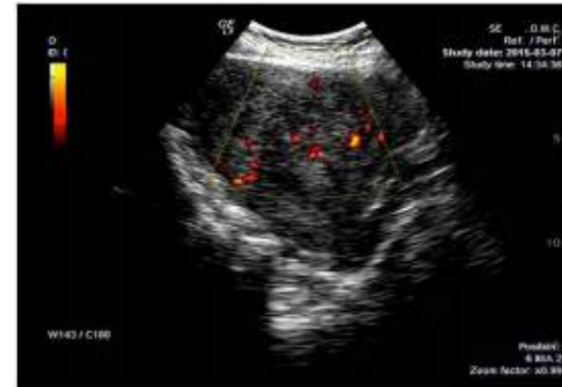
[2] 자궁샘근증(=선근증)

★ 자궁샘근증과 자궁내막증 주요 임상 증상을 2가지씩 쓰시오. '19

★ 자궁선근증의 임상적 의의와 한의학적 치료 '11/ 조직병리학적 기전 '12

★ 자궁내 점막의 점막하층의 부재로 腺의 기질 침윤으로 발생하는 질환은? '04

정의	자궁내막조직이 자궁근층내로 침투. 癥瘕 / 월경과다 / 봉루 /통경	
병기	- 자궁의 경우 밖으로 뿔어져 나가는 것은 허용하되 조직 내로 파고드는 것은 막는 역할을 하는 “점막하층”이 존재하지 않아, 특정한 원인이 발생하면 자궁내막선이 자궁 쪽으로 침투해 들어갈 수 있게되는 해부학적인 구조를 가짐 (나선상혈관이 자궁강 쪽으로 자라나야 정상인데, 자궁근육층 쪽으로 자라나거나, 자궁근육층에 자궁내막조직의 간질이 차서 발생) - 소파술이나 제왕절개: 자궁내막선에 직접적인 손상을 가하게 되면 내막선 조직의 변성이 일어날 확률이 높아져서 샘근증이 일어날 가능성 높아짐 (But, 이것이 직접적인 원인 인자는X)	
호발 연령	40대 이후	
원인	불명, 다빈도 출산, 유산, 특히 D&C(소파술), C/S(제왕절개)에서 증가 양상	
의의 /증상	월경과다	자궁내막선이 원래보다 더 많이 자라므로 월경량이 많아짐 (빈혈 유발 가능 / 자궁내막증과 달리 월경 과다 & 통증 기간 짧음)
	월경통	자궁근층 내로도 월경혈이 들어가 있어, 이를 내보내기 위해 자궁근층이 과잉수축하므로 월경통 심함 (원발성 월경통보다 통증 큼)
진단	sono	
치료	어혈의 범주로 치료, 급즉치기표 완즉치기본 (急則治其標 緩則治其本) 원칙 (월경과다가 있을 때는 월경기, 비월경기 구분하여 치료)	
	월경기 치료	통증에 대한 적절한 처치 + 월경과다에 대한 출혈량을 조절 / 출혈로 인한 혈허에 대한 보상치료
	비월경기 치료	기체혈어에 대해 활혈행기거어 + 징하(혈종)는 파어소징



↑환자가 들고 온 영상에 도플러 효과 들어가있으면 전부터 자궁선근증

6. 치료와 관리

[1] 치료목표

- 원발성: 통증 조절 / 속발성: 원인 질환 치료 병행
- 월경기: 調血止痛의 治標法
- 비월경기: 체질 및 병인을 고려한 治本法

→ 교과서에는 치료 목표를 위와 같이 설명하나 실제 임상에서는 이대로 하기 어렵다고 말씀하심. 월경기와 비월경기를 구분하는 목표는 '장하편'에 적용되며, 임상에서 월경기에는 월경량이 과다해 지지 않도록 활혈거어, 이기시키는 처방(지유, 측백, 건강 등을 초후)으로 월경량을 조절하는 것이 우선시됨. 이론적으로는 월경기에 지통시키는 것이 맞는 이야기지만 실제로 적용되기에는 어려움 <이유> 지통시키는 약(유향, 몰약, 오령지 등)은 1) 가격이 비쌌어도 진통제(타이레놀 등)에 비해 효과가 명확하지 않음. 2) 유향, 몰약을 복용시키는 방법이 까다로움 3) 복용량을 몸무게에 맞춰 정하기가 까다로움

[2] 침 치료와 관련된 논문보고

① 치료 효과	- 침은 원발성 월경통의 NSAID 치료군과 침 치료군 비교했을 때 통증 감소율에서 두 군 모두 유효했음. - 침은 속발성 월경통에 대해 통증 관리의 주된 치료법 및 질병에 대한 보조적 치료법으로써 일정한 효과를 보임. - 침치료 하나만으로 속발성 월경통을 치료하는데에는 한계가 있다고 생각하여 보조적 치료법으로의 효과를 지닌다고 설명
② 득기감	- 득기와 치료 효과와의 상관성은 심리적 인자와 치료효과와의 상관성보다 더 강함. 득기는 월경통에 대한 침치료 효과 발현에 중요한 인자
③ 전침자극 / 온열치료	- 전침 자극: 자궁내 미세순환 개선을 통해 월경통을 개선함. - 온열효과: 자침 시 노출되는 하복부 온도 저하는 자궁평활근의 반사적 수축을 유발할 수 있어 통증을 심화함. 따라서 온열치료 효과로서 이를 개선시킬 수 있음.
④ 치료시간	- 치료 지속 15분 후 통증 감소 효과 - [권고 치료시간] 비월경기: 15-20 분 / 월경기: 20 분-30 분
⑤ 치료 개시시점	- 적정 치료 개시 시점에 관해서는 논란이 있으나, 다수의 논문에서 예정 월경일 5~7 일 전 격일 적용하기를 권장함. - 다수 경혈의 적용 시에는 월경 전에 치료를 시작하는 것이 좋음 - 월경통 개시 시점에서 즉각적인 치료를 적용할 때는 경외기혈인 십칠추 한 개 경혈에 대한 치료가 더 효과적임. 교수님은 십칠추 적용해봤는데 효과 완전 없었음. 비추
⑥ 효과 지속시간	- 치료 효과 지속 기간은 3개월 정도 - 12 개월까지는 치료군이 조금 더 유효한 결과를 보였음

[3] 변증치료 p.110 ★★★★★ ★ 실증성 월경통의 변증 2가지와 대표처방을 쓰시오. '19

	허증		실증	
	기혈허약	간신후손★ '11,13	기체혈어★★ '13,14,17,18	한습응체★★ '11,13,15,17
치법 (언급X)	보혈익기 조경지통	보신양혈 조간완통	활혈화어 이기행체지통	온산한습 활혈화어이지지 통
약물치료	십전대보탕 성유탕	대영전 소영전 조간탕	¹ 현부리경탕★ 격하축어탕	소복축어탕 ² 통경탕
침구치료	삼음교 족삼리 관원 기해 지기 격수 폐수 치료	삼음교 족삼리 관원 기해 태계 격수 신수	삼음교 기해 공손 지기 혈해 태충 합곡 중극 차료	삼음교 족삼리 관원 기해 열결 조해 중극 신수 명문

- 기혈허약/간신후손에 해당하는 환자는 많지 않으며, 대부분 기체혈어, 한습응체 환자들!

① ★현부리경탕 (=격하축어탕의 변방으로 월경통의 기본방)

- 출전: 청강의감
- 구성: 향부자 **창출** 오약 현호색 진피 당귀 백작약 천궁 지각 **봉출** 도인 **육계** **목향** 홍화 생강 (격하축어탕 去 오령지 목단피 加 창출 봉출 육계 목향)
- 창출: 담어동원론에 입각하여, 담을 삭혀서 어를 물러가게 하기 위함.
- 향부자: 동변초 한 것 쓴다. 하초로 작용하는 기운 강해짐.
- 봉출: 파어작용 / 육계: 온경 / 목향: 이기
- 현호색: 활혈거어 작용이 가장 세고, 이기/서근 등이 주된 작용. 이 외에도 진경, 지통, 항궤 양 작용이 있음. 여러 곳(간,비,폐 등)에 귀경하는 팔방미인 약물이지만, **임신 신용약**(신중하게 사용해야 하는 약물)이므로 주의!
- [CASE 썬] 혈괴도 있고 혈허 증상도 있고 통증도 있는 환자에게 현부리경탕을 사용했는데 NRS 가 똑같았음. 이후 온경시키는 약을 가미해서 다시 치료했는데도 똑같았음. 그래서 십전대보탕과 비슷한 가미대보탕을 처방하였는데 효과가 있었음. 환자가 NRS 8로 자궁을 때어놓고 싶을정도로 극심한 통증을 호소했음에도 불구하고 허증 약이 들은 사례. 그럼에도 일반적으로는 월경통 처방은 현부리경탕을 사용함.

- ✓오령지를 넣는 것을 추천
- 교수님曰 “오령지를 왜 뺐는지 모르겠다. 가감법에 冷痛에는 목단피를 가하라고 하였는데 이것도 왜 뺐는지 모르겠음. .통증이 심하면 실소산을 넣으라고 되어있는데 굳이 왜 뺐는지 모르겠다고 하심. 창출이 들어간 것은 어혈이 있는 곳에 담이 있다고 생각해서 들어간 것 같고 봉출은 화어활혈 작용 강화, 육계는 온경, 목향은 이기를 위해서 가미함. 교수님께서 오령지는 빼지 않는 것을 추천함. 요통이 더 심한 경우가 있고 소복통이 더 심한 경우가 있는데 어떤 통증이 더 심한지에 따라 소회향, 두충을 가미할 것.

② **통경탕** : 중국처방이며, 조구등이 군약임.

★경련성 하복통, 경련성 복통에서는 조구등이 의미있는 약물이므로 활용 추천

[4] 임상 연구 증례 및 보고

- 한약: 현부리경탕가감방, 가미소요산
- 이침: 교감 신문 자궁 내분비 피질하
- 약침: 자하거약침(비월경기에 다용) 중성어혈약침(월경기에 다용)
작감탕이 들어간 근이완제도 많이 활용 / 천추 관원 족삼리 혈해
- 구법: 기해 관원 중극 삼음교 현종
- 쑥 좌훈
- TENS

[5] 서양의학적 치료 - 원발성 월경통에 대한 내과적 치료

종류	대표 성분명	성분 함유 대표 상품명
Analgesic 진통제	Acetaminophen 아세트아미노펜	<u>Tyrenol</u> , Geworin, Penzal
	NSAIDs	<u>Ibuprofen</u> , Naproxen
	비스테로이드 소염제	Diclofenac, <u>Aspirin</u>
OCP 경구피임약	Levonorgestrel	Levonomin, Mirena, Minivlar, Ellesse, Firstrel
	Danazol	Danazol
	Nafarelin Acetate	Nafarelin
	Norelgestromin	Evra patch
GnRH agonist	Gonadorelin	Relefact
	Progesterone	Crinone Gel, Progestogel
Androgen	Testosterone	Testo Gel, Androlone Gel, Nebido

Analgesic, OCP 을 다용하며, 보통 원발성 월경통에 사용함.

① Analgesic(=진통제) ★

- Acetaminophen : 해열 + 진통까지만 **예** 타이레놀
- NSAIDs : 해열 + 진통 + **소염** **예** 이지엔식스, 그날엔

② OCP(=경구피임약)

- 배란 방지 → P 소퇴로 생성되는 프로스타글란딘 분비 X → 월경통 생기지 않음
- 원발성 월경통에는 의미 있으나 생식작용을 멈추기 때문에 쉽게 권유X

[6] 위험요인 및 생활관리 (다 알거라고 하고 그냥 넘어가심)

위험요인	생활관리
- 연령(20세 이상) - 체중감량 시도 - 우울, 불안 - 사회생활의 어려움(관계형성 장애) - 이른 초경 - 월경 과다 및 연장 - 미산부 - 흡연 (BUT 불확실함)	- 정서적 이완 - 적절한 운동 - 과다한 육식과 가공식품을 제한한 건강한 식생활 - 건강한 성생활 - 적령기 결혼 및 출산 - 모유수유

3장 월경전증후군과 기타장애 p.146

1절 월경전증후군 Premenstrual syn. PMS p.146

1. 개술

1) 월경전증후군, PMS

- 정의: 일상생활에서 방해를 주기에 충분하며, 주기적이며, 지속적이고, 월경과 관련성을 가지는 정서적, 신체적 문제점들. 즉, 월경 전기에 반복되는 월경통을 제외한 전반적인 증후군.

예 유방의 불편감, 체액의 저류, 약간의 체중 증가, 두통, 정서적 불안정, 우울증 등을 포함

- 특징: 월경이 있기 전 4-10일 사이에 나타났던 증상들이 월경과 함께 사라짐
- 경증은 흔한 편으로 가임기 여성의 40%에서 나타나고, 중증은 10% 미만에서 나타남.

2) 월경전증후군의 증상

① 감정의 변화	- 긴장, 흥분, 우울, 과민, 적대감, 슬픔, 감정적 불안정성, 노여움
② 행동 변화	- 사회적 접촉의 기피, 고립경향의 증가, 일하는 습관의 변화 - 싸움을 거는 경향, 울부짖음, 성욕 변화, 의욕과 능률의 저하 - 심적 충동의 조절력 감소
③ 인식 관련 증상	- 집중력 저하, 망설임, 편집증, 자살충동
④ 신체적 증상	- 요배통, 두통, 유방팽창 또는 압통, 관절통과 근육통, 오심
⑤ 자율신경 증상	- 성욕변화, 과면증, 피로, 기면과 흥분 - 오심, 설사, 발한과 심계항진
⑥ 식욕 변화	- 편식 (음식에 대한 갈망 또는 특정 음식 회피), 식욕감퇴
⑦ 체액/전해질 변화	- 복부팽만, 체중증가, 부종과 땀
⑧ 운동 변화	- 조정기능변화, 움직임 어색함, 어지럼증, 현훈과 진전 - 감각 이상
⑨ 다른 증상들	- 여드름, 기름기 많거나 건조한 머리카락

2. 원인적 요인

★ 월경 전 증후군의 원인적 가설에 대해 쓰시오 (13, 18) 총 8가지 가설

① 프로게스테론설	프로게스테론: PMS가 월경 전에 나타났다가, 월경과 함께 없어지기 때문에 황체기 P의 변화에 의해서 일련의 증상이 나타날 것이라는 가설 혹은 황체기 E와 P의 역전 현상 (E>P)에 의한 것이라고 봄
② 노르에피네프린 & 도파민설	노르에피네프린, 도파민은 감소 시 우울, 증가 시 흥분 불안을 일으키므로 월경 전기에 노르에피네프린이나 도파민에 변화가 생겨서 PMS가 나타날 것이라는 가설
③ Vit. B6 결핍설	Vit B6는 도파민과 세로토닌의 합성에 필요한 중요한 보조효소 → Vit B6가 월경 전기에 특정한 이유로 부족해져서 문제가 발생하는 것이라는 가설
④ 저혈당설	저혈당의 증상(발한, 피로, 두통, 심계항진 등)이 PMS의 증상과 유사하다는 점이 있다는 가설이나. PMS환자와 정상인 사이에 혈당의 차이는 규명하지 못했음
⑤ 체내 호르몬에 대한 알리지설	월경전기에 프로게스테론 확 늘어나고, 프로락틴의 자극도 많아지는데, 이런 호르몬들에 대해 알리지 현상을 보이는 것이 원인일 것이라는 가설
⑥ 수분, 염류 조절 호르몬 이상설	PMS에서 체중증가와 수분저류 현상이 증가하여 부종을 잘 일으키기 때문에 대두된 원인론
⑦ β-endorphin 이상설	β-엔돌핀, 엔케팔린, 디노르핀 등 '내인성 오피오이드'가 (황체기 직전에 최고 수준에 이르렀다가) 월경기 쯤에 최저점을 찍는데, 이 때문에 기분 안 좋아지고 여러 가지 정서적 변화가 생길 수 있다는 가설
⑧ 정신과 원인	잠재되어 있던 정신과적 문제가 월경 전기에 드러난다는 가설

★[강조] 월경전 증후군의 주증상에 따른 4분류를 쓰시오.'12, 19

비율상 1위: 정신적 긴장, 2위: 증가된 식욕이라는 것 알아두기

분류	비율	내용
흥분/과민/정신적 긴장	80	- 원인: 증가된 E-P 비율 - 황체기에 점차적 악화 / 월경기에 호전 - 때때로 우울증이 동반
체중증가 & 수분저류	40	- 원인: 증가된 알도스테론과 신성 도파민 결핍 - 복부팽만, 유방압통, 두통 - 안면과 말단부 부종
음식에 대한 갈망 & 증가된 식욕	44	- 기절, 피로와 두통 - 증가된 탄수화물 불내성 - 기복없는 내당곡선
우울	20	- 원인 : 낮은 E-P 비율 - 자살 감정 - 혼돈, 기면과 모순된 생각

3. 진단

- 진단시 설문에 의존할 수 밖에 없음 → PAF 활용

★ PAF (premenstrual Assessment Form) - 5가지 유형의 PMS 지표'14

- ① 주요우울 증후군 ② 수분저류 증후군 ③ 일반적인 불쾌감 증후군
④ 충동 증후군 ⑤ 사회기능장애

※ PAF

- PAF: 임상보다는 논문을 작성할 때 주로 활용하는 **월경전기 평가표**
- 총 95개의 문항으로 이루어진 설문지. 월경전증후군을 대략 5가지 유형으로 묶어서 분석이 가능하도록 하였음. 단, 실제 임상에서 적용하기에는 무리가 있고, 주로 연구할 때 사용
→ 매일 체크해야 하기 때문에 귀찮고 협조도 어려운 문제점때문
- 월경전기의 감정, 행동, 신체적 변화를 모두 포함하는 것으로, 이 변화들을 특징하는 동질군으로 분류할 수 있는 범주를 마련하고, 각 증후군에 대한 비교적 정확한 기준이 있다는데 의미가 있음.
- [단점] 후향적 검사에 해당, 전향적 평가가 애초에 거의 불가능함을 감안하였을 때 현재 PMS의 거의 표준적 진단법으로 활용 (후향적 평가는 증상이 과장되기 쉬운 단점)

4. 치료 (대증치료)

분류	치료 접근	
흥분, 과민	- 상담 및 교육 - Tranquilizers - Pyridoxine	- Progesterone (400mg, intravaginal)
체중증가	- 이뇨제	
유방통	- Spironolactone (50mg) - Parlodel (2.5mg) - 침상 안정과 지지대의 착용	- 카페인 섭취를 줄임 - Danazol (100-200mg)
식욕증가	- 고단백, 저당의 음식	- Pyridoxine
우울	- 상담 - 정신과 병력 청취 - 자살 가능성의 평가 - 객관적인지지	- Progesterone - Duphaston - Pyridoxine - Spironolactone

※프리페민

- 어원: 여성을 해방시킨다는 의미에서 나온 이름
- 팔로델과 유사한 약으로, 일종의 도파민 효능제
- 프리페민은 PRL을 억제하여 경전유방창통을 없애고, P를 낮아지게 만듦. (PL & P = 갈항)
- 결과적으로 E과 P가 역전된 병리상태 (E과잉으로 P보다 커진 상태)를 정상화(재역전)시킴. (E<P로)

→ 효과가 있는지에 대한 케이스가 명확하지 않아 아직 효과를 모르겠다고 하심.

- 단점: 투약 3개월 이상 필요
- 프리페민은 생약 추출약으로 **서양 순비기나무**에서 추출함.

***순비기** 나무에서 나오는 열매 = 만형자 (서양 순비기 나무와 다르긴 함.)

- 만형자는 교감신경 흥분, 혈관 수축, 구역, 구토, 구강 건조의 부작용이 있음.(도파민 효능제)
→ “몸의 구멍에서 나오는 물을 말린다”
- 소산풍열/청리면목 시키는 약재로, 긴장성 두통/목예증/만성중이염 등에 씀.

2절 경행병과 월경전증후군 p.152

- 경행병: 월경과 더불어 나타날 수 있는 여러 가지 증상을 포괄
- 관련 질환: (경행)정지이상 (경행)두통 (경행)현훈 (경행)부종 (경행)토혈 (경행)발열 (경행)신통 (경행)설사 (경행)구미 (경행)풍진 (경행)유방창통

*월경 중에 무슨 일이 생겼다, 월경전증후군 의미= '경행'이라는 말이 붙음.

① (경행)정지이상

월경 전 불안, 긴장, 우울, 민감, 슬픔, 감정의 불안정, 분노 등의 정서적 변화가 일상생활에 지장을 줄만큼 충분히 **주기적이고 지속적**으로 나타나는 것

→ 경행병의 가장 큰 특징은 주기적이고 지속적으로 나타나는 것

변증	임상 증상	치법	처방
심혈부족 (心血不足)	심계정충, 실면, 건망, 안색에 생기가 없고 권태로운 증상	보혈안신	감맥대조탕 가미귀비탕
간기울결 (肝氣鬱結)	화내는 것이 자제되지 않고, 속이 타서 갑갑하고 불편하며 두통이 잘 생김. 입이 쓰고 입술이 마르며 가슴이 답답.	소간해울	단치소요산
담화상요 (痰火上擾)	정신이 맑지 않고, 가슴이 답답하고 밤에 잠자리에 누워도 편치 않음. 식욕이 없고 변비가 있음.	조습거담	온담탕

*변증이름-처방 언급만하고 넘어가심

- 온담탕, 소요산, 귀비탕이 정서적 반응 자체를 없애주는 것이 아님.
- 어떤 식으로 작용할지 정신과적 처방들에 대해 고민할 필요가 있음. (정신과시간에 잘 알려줄 것이라고 하시고 넘어감)

② (경행)두통

월경기 혹은 월경 전후에 주기적으로 나타나는 두통

변증	임상 증상	치법	처방
혈허(血虛)	두통이 은은하게 지속, 어지러움. 심계, 피로.	자음양혈	가감기국지황탕
간화(肝火)	양측 태양혈을 중심으로 동통 발생, 충동적 동통(폭폭 찌르는 듯함), 홍민, 심번, 구고, 변비, 목적, 유방창통 동반.	청간사화	영각구등탕
혈어(血瘀)	찌르거나 터질 것 같은 두통, 동통 부위 일 정	조기활혈 화어통락	통규활혈탕
담습(痰濕)	두혼(머리가 무거우면서 아픔), 체비(체격이 비만), 부종	화담조습 강역지통	반하백출천마탕

*변증이름-처방 언급만하고 넘어가심

- 통규활혈탕: 축어탕 3총사에 대한 개념 잘 알아두라고 하고 넘어감

③ (경행)현훈

월경주기에 맞추어서 반복적으로 어지러운 것이 나타나는 것

이석증 있는 사람은 월경기에 더욱 심해진 어지럼증을 호소하기도 함.

변증	임상 증상	치법	처방
혈허 (血虛)	어지러우면서 피로하고 안색이 창백하다. 음식 섭취량이 적고, 잠을 잘 못이름	보기양혈	귀비탕
음허양항 (陰虛陽亢)	속이 타고 갑갑하여 불안정하며 성을 잘 내고 입이 마르고 귀가 울림.	자음잠양	천마구등음
담습 (痰濕)	머리가 무거우면서 어지러움. 비만한 경우가 많고, 부종이 잘 생김.	조습화담	반하백출천마탕

*변증이름-처방 언급만하고 넘어가심

- 영계출감탕, 반하백출천마탕, 시호가용골모려탕 이 세가지 처방의 활용도 높음

④ ★ 월경 전 부종과 특발성 부종 '11,17 (병인, 병기)

★ 한의학에서 월경전 부종은 그 병인병기를 대개 (비신양허)로 보고, 특발성 부종의 병인병기는 (기체혈어)에서 많이 찾고 있다. '05

변증	증상	병인병기	처방
월경전 부종 '17	월경 전 신체 곳곳 부종 (월경의 주기적 특성과 관련)	비신양허 脾腎陽虛	영계출감탕 진무탕 苓桂朮甘湯 眞武湯
특발성 부종 '17	특별한 원인/월경과 뚜렷한 관련 x (여성의 심신의학적 특성과 관련)	기체혈어 氣滯血瘀	*분심기음 分心氣飲

- 진무탕: 부자 들어간 처방 교수님은 잘 안씀
- 영계출감탕: 메니에르병 등에도 활용되는 활용도 높은 처방
- 분심기음: 임상 활용도 높아보이지만, 한번도 제대로된 효과를 못 봤음.

⑤ 대상성 월경 교수님은 임상에서 한번도 못 봄.

- 월경주기에 일치하여 주기적으로 자궁 외 장소에서 출혈 예 월경 중 비점막 출혈
- 에스트로겐 작용으로 비점막 출혈이 발생하기도 한다고 함. PMS 중 비염도 꽤 있음, 자궁내막 증후자가 비점막 관련된 질환으로 오는 경우도 있음.
- 뇌압이 높아져서 비점막이 예민해지거나 발생학적 기원 등이 원인이 되기는 하나 실제로 본 적은 없음.

변증	임상 증상	치법	처방
간경울화	속이 갑갑하고 불편하며 성을 잘 내고 가슴과 옆구리가 아픔. 입이 마르고 어지러움.	소간청열 인혈하행	청간인경탕
위열치성	입이 마르고 입냄새가 나며 변비가 있음	청위설열 평충강역	삼황사물탕 서각지황탕
간신음허	어지러워하며 귀가 울리고 조열이 있으며 손/발바닥에 열이 남.	자신윤페 인혈하행	순경탕

*변증 거의 언급 X

3단원 대하 및 기타 생식기 질환 p.295

1장 대하 p.297

1절 개술 p.297

1. 대하의 의미

- 정상상태에서 모든 생식기의 점막은 그 자체의 분비물이나 내강의 상부로부터 나온 분비물로 적셔져 있음. 이러한 분비물은 소수의 여성에서는 간혹 외부로 흘러나오지만 정상적으로는 질 밖으로 배출되지 않는 것이 보통임.
- 대하는 출혈 이외 질 분비에 적용되며, 정상 분비물의 양이 많아지거나 생식 내강의 어느 부위에 병적인 상황이 진행되어 나타나는 이상 삼출물을 의미
- 한의학적으로 대하는 대맥을 따라 흘러내리는 것 : 從帶脈以下(여성 성기의 분비물 총칭)
- 한의학적 병인: 습 (+ 열 OR 한)
 - 급성인지 허증인지에 따라 변증되나, 기본적으로 습이 제일 중요

1) 광의의 대하

- 보인지병 인허 적냉... 차개대하 <금궤요략>
- “대하의” <사기 편계창공열전> = 대하만이 아니라 전체적인 부인과 의사를 모두 지칭하는 말
- 생리, 병리 모두 포함한 전체적인 부인과적 질환을 의미하는 대하

2) 협의의 대하

- 임맥위병...여자대하하취 <소문>
- 병생우대맥 고명대하 <교주부인대전양방>
- 병리적 의미의 대하만 말한다

2절 대하 유발 부위 p.298

1. 외음부

- 외음부에 존재하는 분비선: 피부기름샘, 땀샘, **바르톨린선(Bartholin's gland)**, 스케네선(Skene's gland)
- 바르톨린선: 질입구와 질점막의 윤활작용에 중요한 역할, 특히 성행위 시 진한 점액을 분비.
- 바르톨린선 감염 시 파열된 농양으로부터 많은 양의 농이 나옴. 환자들은 이러한 분비물 혹은 요도주변 구성물로부터의 분비물을 질 분비물로 오해하기 쉬움. 이들 부위의 염증은 주로 임균에 의하지만 클라미디아 등 다른 세균에 의해서도 발생할 수 있음.
- 전정의 요도 주변부: 스케네샘의 관이 위치하며, 여러 개의 점액성 음와가 존재하여 외음부 구조물에 윤활작용
- 대하와 관련하여 외음부 소양증을 주로 호소하는 환자는 당뇨병과 연관이 있는가도 반드시 검사해야 함. (당뇨병 환자는 특히 진균류 감염, 칸디다 감염에 취약함)

2. 질

1) 정상 질

- 피지선, 한선, Bartholin's gland, Skene's gland 등의 분비물, 질벽의 여출액 및 질 자궁경부에서 유래한 세포
- 자궁경부 점액, 자궁내막과 난관에서 나오는 액, 미생물과 그 대사물질 존재
- 탈락 세포의 형태, 양, 자궁목관점액, 상부의 난관액은 호르몬의 양에 영향을 받으며, 그 양은 생화학적 진행에 의하여 결정됨.

★ ()의 영향을 받은 질 상피세포는 ()이 풍부 '08 **에스트로겐**, **글리코겐**

★ vaginal pH balance 질의 자정작용 '10(질의 면역작용), 14(질감염을 막는 방어인자)

- 정상 질 내부는 호기성 균이 많고 과산화수소를 생산하는 유산균(lactobacilli)이 가장 흔함
- 정상 질 산도: 4.5 이하 (평균 pH3.8) ← 유산(lactic acid)의 생산에 의해 유지됨
- 질은 공기가 잘 안 통하는 장소이다 보니 혐기성세균이나 곰팡이등이 서식하기 쉬움. But, 질은 자정작용이라는 면역기능에 의해서 이들을 방지할 수 있음.
- [기전]
 - ① **에스트로겐**이 질 점막에 작용
 - ② 질 점막에 **글리코겐**이 풍부해짐
 - ③ 글리코겐이 질 상피세포에 의해 단당으로 분해됨
 - ④ 유산균(doderline bacillus)이 단당류를 먹고 유산으로 변환시킴
 - ⑤ 유산간균이 **과산화수소(H₂O₂)** 배출 & pH 3.8로 유지
 - ⑥ 이를 통해 에스트로겐의 자양을 받는 질은 산성을 잘 유지함.

*포도상구균은 pH4.5 이하로 떨어지면 증식을 멈춤. 잡균들은 pH 5.5 이하로 떨어지면 소멸.

- PCOS 환자 등 부인과 환자를 볼 때 이상분비물 여부를 확인해야 함. (질의 자정작용, 즉, 질의 면역 상태가 에스트로겐과 연관되므로 이를 확인하기 위해서)

※ 질 분비물

- 질 분비물은 월경주기의 중반에 자궁목관점액의 증가로 많아짐.
- 정상적 질 분비물: 솜모양으로 흰색이고, 보통 낮은 부분인 후방 질정에 고임
- 질 분비물을 식염수(saline)으로 적셔서 슬라이드에 도말한 후 분석함
- 생물학적 검사 상 많은 상피세포, 약간의 백혈구(백혈구는 적음), 몇 개의 *clue cell 이 관찰됨
- 10% KOH 를 슬라이드에 첨가(=Whiff test)하여 곰팡이 여부 진단 가능
- Whiff test 에서 냄새만 가지고 진단할 수 있는 것은 세균성 질증!

※ clue cell

- ① 실타래상 세포(실타래 모양), & ② 세균성 질염의 단서(clue)라는 중의적 의미
- 질 상피세포 표면에 많은 세균이 엉켜있는/부착되어 있는 것이 clue cell